EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 83763
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-04 11:05:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: LUIS EDUARDO CARO CARO			RUN	: 13.127.242-1
F.Nac	: 05-07-1977	Edad	: 46 AÑOS, 9 MESES	Género	: Masculino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-04-27	Fecha Egreso	: 2024-05-04 11:05:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G00.9-MENINGITIS BACTERIANA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Meningoencefalitis bacteriana aguda
a. Streptococcus pneumoniae multisensible
2. Epilepsia post TEC
3. Obs Fistula LCR
4. Usuario de protesis ocular

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G00.1-MENINGITIS NEUMOCOCICA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. G40.9-EPILEPSIA, TIPO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. H54.4-CEGUERA MONOCULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino de 46 años con antecedentes de refiere TEC antiguo, con sospecha de fistula de LCR, Meningitis 2021-2023 por S. pneumoniae, epilepsia secundaria, usuario de prótesis Ocular, es traido via SAMU al HSC el dia 27/04 por presentar movimientos tónico clónicos en la vía publica, al ingreso paciente febril en estado post ictal; presentando nuevamente crisis tonico clónica que mejora tras la administración de Lorazepam EV posterior a eso se evidencia hemiparesia derecha por lo cual solicitan evaluación de neurología por posible ACV en ventana, paciente mejora déficit tras la administracion de levetiracetam por lo cual no impresiona stroke y sugiere estudio de LCR ante la presencia de fiebre y convulsiones. Se realiza TAC de cerebro en urgencia con área de encefalomalacia frontal izq. AngioTAC sin hallazgos patológicos. Paciente destaca signos meníngeos positivos, por lo que se realiza PL que evidencia salida de LCR aspecto lechoso, se inicia aislamiento y hospitalización con terapia antibiótica dual empírica a dosis meníngeas, con ceftriaxona + vancomicina, se recibe antibiograma que evidencia cultivo LCR S. Pneumoniae + MS, por lo que tras dos días recibiendo vancomicina ajustado según niveles se suspende para continuar con ceftriaxona. Paciente de evolucion actual favorable, estable desde el punto de vista hemodinamico, eupneico, se mantiene afebril, tranquilo, cooperador, se ha mantenido sin crisis convulsivas, no refiere molestias, tolerando bien alimentación via oral y deambulacion. con buena respuesta clínica y paraclinica, examen físico sin conficto. actualmente completando terapia con antibiotica solo con ceftriaxona en su 7mo dia con plan de completar 14 dias en domicilio, paciente reside en san Carlos.

PLAN DE MANEJO:

-Durante hospitalización se realiza ic a neurocirugía por resolución de Fistula de LCR pendiente, actualmente sin rinorraquia.
-Continuar con terapia antibiótica EV hasta completar 14 dias en HODOM, tratamiento cronico de base mas kinesioterapia motora.

INDICACIONES AL ALTA

1. 1. Reposo relativo
2. 2. Régimen común liviano
3. 3. hidratacion oral
4. 4. kinesioterapia motora en HODOM
5. 5. omeprazol 20 mg vo c/dia por 10 dias
6. 6. Ceftriaxona 2gr c/12 horas EV por 7 dias (hasta completar 14)
7. 7. levetiracetam 500mg 3 comp c /12 horas vo
8. 8. paracetamol 500mg VO 2 comp c/8 horas sos dolor
9. 9. Pendiente respuesta de ic a neurocirugia ambulatoria
10. 10. Ante signos de alarma reconsultar sos

EXÁMENES Y RESULTADOS

Cultivo LCR: + S.pneumoniae multisensible
Niveles Vancomicina: 7.0
R.P.R: no reactivo
Glicemia 93 mg/dl | Creatinina 0,80 mg/dl | Clearence Calculado(MDRD) 104,07 ml/min/1,73 | Proteina C Reactiva 18,9 mg/L | Nitrógeno Ureico 25 mg/dL | Uremia 53 mg/dl | Sodio 138,00 mmol/L | Potasio 4,80 mmol/L | Cloro 100,00 mmol/L | Recuento de leucocitos 15,40 mil/ul | Recuento Hematies 5,25 Mill/ul | Hematocrito 46,9 o/o | Hemoglobina 15,6 g/dl | V.C.M. 89,4 fl | H.C.M. 29,7 ug | C.H.C.M. 33,2 g/dL | R.D.W. 12,8 o/o | Plaquetas 339 mil/ul | Segmentados 80 o/o | Linfocitos 9 o/o | Monocitos 11 o/o | Eosinófilos 0 o/o | Basófilos 0 o/o | VHS 29 | INR 1,04 | Tiempo de Protrombina % 94 o/o | Tiempo de Protrombina seg 13,8 seg | Procalcitonina 0,17 ng/mL |

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO